

CAPÍTULO 13.43

Enfermedades Intersticiales, Neumoconiosis, Hipertensión Pulmonar y Cor Pulmonale

PERFIL EUNACOM 1.011.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El tabaquismo es una de las principales causas de morbilidad prevenible a nivel mundial. En el examen EUNACOM, se pregunta con frecuencia tanto por sus riesgos asociados como por las estrategias de tratamiento para la cesación tabáquica.

Riesgos del Consumo de Tabaco

El cigarrillo afecta prácticamente todos los órganos del cuerpo, siendo un factor de riesgo mayor para:

- **Riesgo Cardiovascular:** Es un pilar fundamental en la génesis de la aterosclerosis. Aumenta el riesgo de **Accidente Cerebrovascular (ACV)**, **Infarto Agudo al Miocardio (IAM)**, claudicación intermitente (enfermedad arterial periférica) y aneurisma de aorta abdominal.
- **Cáncer:** No solo se limita al **Cáncer de Pulmón**. También aumenta significativamente el riesgo de cáncer en: boca, lengua, nariz, esófago, laringe y vejiga.
- **Patología Respiratoria:** Es la causa principal de **EPOC** (que engloba tanto el enfisema pulmonar como la bronquitis crónica).
- **Otros:** Complicaciones en el embarazo, envejecimiento prematuro de la piel y patología periodontal.

Evaluación del Hábito Tabáquico: Índice Paquete-Año (IPA)

Para cuantificar la exposición al humo del tabaco, se utiliza el concepto de **paquetes-año**. Un paquete-año equivale a fumar 20 cigarrillos (una cajetilla) al día durante un año.

TABLA 13.43.1: PARÁMETRO VS FÓRMULA DE CÁLCULO

PARÁMETRO	FÓRMULA DE CÁLCULO
Índice Paquete-Año (IPA)	$\frac{\text{Cigarrillos al día}}{20} \times \text{Años fumando}$

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Ejemplo de cálculo: Si un paciente fuma 10 cigarrillos al día durante 30 años: $(10 / 20) \times 30 = 15$ paquetes-año. Este índice es fundamental para decidir el screening de cáncer de pulmón en ciertos grupos de riesgo.

Criterios de Adicción y Dependencia

- No todos los fumadores tienen el mismo grado de adicción. Se sospecha una dependencia severa a la nicotina cuando:
- El paciente fuma **más de 15 cigarrillos al día**.
- Fuma con mayor intensidad o frecuencia durante las **primeras horas de la mañana** (necesidad de recuperar niveles plasmáticos de nicotina tras el sueño).
- Fuma en lugares donde está prohibido.
- Fuma a pesar de estar cursando enfermedades agudas (resfriados, crisis de EPOC) o tener contraindicaciones médicas severas.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Fumar a pesar de tener una restricción médica clara es un signo inequívoco de alta dependencia neurobiológica.

Tratamiento de la Cesación Tabáquica

El abandono del tabaco es difícil y requiere un enfoque multidisciplinario.

- **Consejería Médica (Intervención Mínima):** Todo médico debe recomendar dejar de fumar en cada consulta. Aunque el éxito es bajo (aprox. 5%), es una medida de salud pública costo-efectiva.

- **Psicoterapia Cognitivo-Conductual:** Es la base del tratamiento. Consiste en identificar los "gatillantes" (estrés, café, situaciones sociales) y desarrollar estrategias para evitarlos o manejarlos.
- **Apoyo Farmacológico:** Indicado especialmente en pacientes con alta dependencia o síndrome de abstinencia.
 - **Sustitución Nicotínica:** Parches, chicles o caramelos de nicotina. Ayudan a manejar los síntomas físicos de la abstinencia.
 - **Bupropión:** Antidepresivo que reduce el *craving* (deseo imperioso de fumar).
 - **Vareniclina (Chantix):** Agonista parcial de los receptores de nicotina; es el fármaco más efectivo para disminuir el deseo de fumar.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología del Craving vs. Abstinencia: La nicotina actúa sobre receptores dopaminérgicos. Los fármacos como la vareniclina compiten por estos receptores para disminuir el placer de fumar y el deseo (*craving*), mientras que los parches de nicotina mantienen niveles basales para evitar el síndrome de abstinencia físico (irritabilidad, ansiedad, temblor).

Cigarrillo Electrónico (Vapeo)

Actualmente, **no se recomienda** de forma generalizada como terapia de cesación, ya que mantiene el hábito conductual y no hay evidencia suficiente de su seguridad a largo plazo. Aunque en algunos países se considera un "mal menor", la meta siempre debe ser la cesación total.

Contaminación Ambiental

La contaminación ambiental es un problema de salud pública relevante en Chile, especialmente en ciudades como Santiago (smog) o Temuco (humo de leña).

Riesgos de la Contaminación

- **Infecciones:** Aumento demostrado de infecciones respiratorias virales y neumonías bacterianas, especialmente en invierno.
- **Cardiovascular:** Aumento del riesgo de eventos agudos (IAM, ACV).
- **Cáncer:** Aumento del riesgo de cáncer pulmonar (aunque en menor magnitud que el tabaco).

Medidas de Prevención y Salud Pública

En Chile se implementan diversas estrategias que se clasifican según el enfoque de salud pública:

- **Protección de la Salud (Acción sobre el Medio Ambiente):**
 - Restricción vehicular.
 - Prohibición del uso de estufas a leña en zonas saturadas.
- **Promoción de la Salud (Acción sobre las Personas/Hábitos):**
 - **Ley Antitabaco:** Prohibición de fumar en lugares públicos cerrados (ha logrado bajar el tabaquismo en Chile significativamente).
 - **Restricción Publicitaria:** Prohibición de anuncios de tabaco.
 - **Advertencias Sanitarias:** Fotos e información obligatoria en las cajetillas.

NOTA CLÍNICA

Diferencia clave para Salud Pública: - **Protección:** Se interviene el **entorno** (aire, agua, alimentos). - **Promoción:** Se interviene en los **estilos de vida** y educación de la población.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente de 62 años con disnea de esfuerzo progresiva hace 1 año, tos seca e hipocratismo digital. En la auscultación se escuchan crepitaciones bilaterales basales. Espirometría con patrón restrictivo. TAC de tórax muestra patrón intersticial de predominio basal y periférico. Estudio autoinmune negativo, sin exposición laboral, sin fármacos sospechosos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Enfermedades Intersticiales, Neumoconiosis, Hipertensión Pulmonar y Cor Pulmonale. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Fibrosis pulmonar idiopática: la más frecuente y de peor pronóstico; sin tratamiento específico
- Causas de enfermedad intersticial: FPI, autoinmunes, fármacos (nitrofurantoína, amiodarona), inhalantes
- Clínica: disnea de esfuerzo, tos seca, crepitaciones bilaterales, hipocratismo digital
- Diagnóstico: radiografía + TAC + biopsia pulmonar; espirometría restrictiva; desaturación con ejercicio
- Asbestosis se asocia a cáncer de pulmón y mesotelioma (mal pronóstico, invade cisuras)
- Hipertensión pulmonar: PAS arteria pulmonar > 30 mmHg o PAM > 25 mmHg
- HTP primaria: disnea con radiografía y espirometría normales; ecocardiograma + cateterismo pulmonar
- Cor pulmonale + PaO₂ < 60 mmHg en EPOC: indicación de oxígeno domiciliario

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ENFERMEDADES INTERSTICIALES, NEUMOCONIOSIS, HIPERTENSIÓN PULMONAR Y COR PULMONALE)**PREGUNTA 1**

Paciente de 62 años con disnea de esfuerzo progresiva hace 1 año, tos seca e hipocratismo digital. En la auscultación se escuchan crepitaciones bilaterales basales. Espirometría con patrón restrictivo. TAC de tórax muestra patrón intersticial de predominio basal y periférico. Estudio autoinmune negativo, sin exposición laboral, sin fármacos sospechosos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Sarcoidosis pulmonar
- B)** Fibrosis pulmonar idiopática
- C)** Asbestosis
- D)** EPOC avanzado
- E)** Neumonitis por hipersensibilidad

PREGUNTA 2

Paciente de 55 años, trabajador de la construcción durante 25 años, presenta disnea progresiva y tos. Radiografía muestra patrón intersticial difuso. ¿Cuál es la neumooniosis más probable y cuál es su principal complicación oncológica?

- A)** Silicosis; linfoma pulmonar
- B)** Asbestosis; cáncer de pulmón y mesotelioma
- C)** Neumoconiosis del carbón; cáncer de esófago
- D)** Beriliosis; leucemia
- E)** Silicosis; cáncer de pulmón

PREGUNTA 3

Paciente de 40 años con disnea de esfuerzo progresiva. Radiografía de tórax normal. Espirometría normal. Ecocardiograma muestra presión sistólica de arteria pulmonar estimada en 55 mmHg. No tiene antecedente de insuficiencia cardíaca ni patología pulmonar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el examen confirmatorio?

- A)** EPOC; espirometría con broncodilatador
- B)** Fibrosis pulmonar idiopática; TAC de tórax
- C)** Hipertensión pulmonar primaria; cateterismo pulmonar
- D)** TEP crónico; angioTAC de tórax
- E)** Insuficiencia cardíaca oculta; BNP sérico

RESUMEN: ENFERMEDADES INTERSTICIALES, NEUMOCONIOSIS, HIPERTENSIÓN PULMONAR Y COR PULMONALE

Las enfermedades intersticiales pulmonares difusas tienen múltiples causas, siendo la fibrosis pulmonar idiopática (FPI/UIP) la más frecuente y de peor pronóstico, sin tratamiento específico más allá del sintomático (oxígeno, salbutamol). Otras causas incluyen enfermedades autoinmunes (esclerodermia, sarcoidosis, artritis reumatoide, lupus, dermatomiositis), fármacos (nitrofurantoína, amiodarona, metotrexato, quimioterapia) e inhalantes (neumoconiosis). La clínica es disnea de esfuerzo, tos seca, crepitaciones bilaterales, hipocratismo digital y pulmones de tamaño pequeño. El diagnóstico se basa en radiografía (patrón intersticial, mayor en bases y periferia en FPI), TAC de tórax y biopsia pulmonar para identificar la causa específica. La espirometría muestra patrón restrictivo. El test de caminata demuestra desaturación con ejercicio y el test de difusión de CO muestra disminución, ambos característicos del trastorno de difusión propio de estas enfermedades. Una anamnesis completa (exposiciones laborales, mascotas, fármacos, síntomas autoinmunes) es fundamental para buscar la causa tratable. Las neumoconiosis son enfermedades laborales por inhalación crónica: silicosis (exposición a sílice/vidrio/loza), asbestosis (materiales de construcción, asociada a cáncer y mesotelioma) y neumoconiosis del carbón. El mesotelioma tiene mal pronóstico, invade pleura y cisuras, produce derrame pleural maligno. La hipertensión pulmonar se define como presión sistólica de arteria pulmonar mayor a 30 mmHg o media mayor a 25 mmHg. La primaria cursa con disnea, radiografía y espirometría normales; se estudia con ecocardiograma (indirecto) y cateterismo pulmonar (confirmatorio). Tratamiento: oxígeno, óxido nítrico, prostaciclina, sildenafil. La secundaria (más frecuente, por ICC o patología pulmonar) se trata manejando la causa. El cor pulmonale es insuficiencia cardíaca derecha secundaria a patología pulmonar; es indicación de oxígeno domiciliario en EPOC cuando PaO₂ menor a 60 mmHg.